

Đường rò — Tiết niệu-sinh dục và Trực tràng-âm đạo

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Đường kết nối bất thường gây rò nước tiểu, hơi hoặc phân

Đường rò (fistula) là một đường hầm bất thường giữa hai cơ quan không đáng lẽ phải thông nhau. Ở vùng chậu, đường rò có thể hình thành giữa **bàng quang (hoặc niệu quản/niệu đạo)** và **âm đạo** — gây rò nước tiểu liên tục — hoặc giữa **trực tràng và âm đạo** — khiến hơi hoặc phân thoát ra qua âm đạo. Đường rò khó tự lành, nhưng có thể được phẫu thuật sửa chữa.

Về tình trạng này

- **Rò tiết niệu-sinh dục** (ví dụ: rò bàng quang-âm đạo) — rò nước tiểu liên tục, không kiểm soát qua âm đạo, cả ngày lẫn đêm.
- **Rò trực tràng-âm đạo** — hơi hoặc phân thoát ra qua âm đạo, nhiễm trùng tái phát và kích ứng.

Các triệu chứng này có thể gây lo âu và mặc cảm — nhưng đây là vấn đề về mặt giải phẫu và hoàn toàn có thể giải quyết được, không phải lỗi của bạn.

Nguyên nhân

- **Phẫu thuật vùng chậu hoặc phụ khoa** (như cắt tử cung) — nguyên nhân phổ biến nhất ở nhiều quốc gia
- **Sinh con** — đặc biệt là chuyển dạ kéo dài hoặc bị tắc nghẽn (nguyên nhân hàng đầu trên toàn cầu)
- **Xạ trị**, bệnh viêm ruột, nhiễm trùng, hoặc (ít gặp hơn) ung thư

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Đường rò

Đường hầm bất thường nối hai cơ quan.

Rò bàng quang-âm đạo

Đường rò giữa bàng quang và âm đạo.

Rò trực tràng-âm đạo

Đường rò giữa trực tràng và âm đạo.

Thử nghiệm thuốc nhuộm

Bơm dung dịch màu vào bàng quang/trực tràng để xác định vị trí rò.

Nội soi bàng quang

Dùng camera quan sát bên trong bàng quang để tìm lỗ rò.

Vật Martius

Vật mô được dùng để gia cố đường khâu phục hồi.

Phân lưu

Biện pháp tạm thời để dẫn nước tiểu hoặc phân trong khi vết thương lành.

CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC KHÔNG? Có — hầu hết đường rò đều có thể sửa chữa, và nhiều bệnh nhân khỏi hoàn toàn. Đôi khi đường rò nhỏ và mới hình thành có thể tự đóng khi đặt ống thông, nhưng hầu hết cần phẫu thuật có kế hoạch. Thời điểm phẫu thuật rất quan trọng: bác sĩ thường chờ tình trạng viêm giảm để tăng khả năng thành công.

Chẩn đoán như thế nào

- Khám lâm sàng, thường kết hợp **thử nghiệm thuốc nhuộm** để xác định vị trí rò
- **Nội soi bàng quang** và chẩn đoán hình ảnh để xác định kích thước, vị trí và nguyên nhân
- Tìm kiếm yếu tố liên quan (ảnh hưởng xạ trị, nhiễm trùng, bệnh viêm ruột)

Điều trị như thế nào

- 1 **Điều trị bảo tồn** — đường rò tiểu nhỏ và mới có thể tự đóng khi để ống thông tại chỗ vài tuần.
- 2 **Phẫu thuật phục hồi** — đóng đường hầm qua đường âm đạo hoặc bụng, thường theo nhiều lớp.
- 3 **Vật mô** — mô khỏe mạnh (như vật Martius) có thể gia cố đường khâu, đặc biệt sau xạ trị.
- 4 **Phân lưu tạm thời** — với một số đường rò trực tràng-âm đạo, phân được dẫn tạm thời để vết khâu lành.

Nên biết

- Bảo vệ da và dùng miếng lót khi chờ phẫu thuật; nhóm chăm sóc có thể hỗ trợ giúp bạn thoải mái hơn.
- Phục hồi sau **xạ trị** phức tạp hơn và thường cần vật mô.
- Bạn có thể cần ống thông và **kiểm tra lành thương** trước khi rút ống.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc đau vùng chậu nặng hơn
- Dấu hiệu nhiễm trùng hoặc chảy máu nhiều
- Sau phẫu thuật: ống thông không dẫn được, hoặc tình trạng rò tái xuất hiện

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Đường rò là kết nối bất thường gây rò nước tiểu (tiết niệu-sinh dục) hoặc hơi/phân qua âm đạo (trực tràng-âm đạo).
2. Hầu hết có thể sửa chữa — một số nhỏ tự đóng với ống thông, nhưng hầu hết cần phẫu thuật, đôi khi cần vật mô.
3. Thời điểm quan trọng; nhóm chăm sóc có thể chờ tình trạng viêm giảm. Báo ngay nếu sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc rò tái phát sau phẫu thuật.